

AVULSÃO — REIMPLANTAR RÁPIDO (TEMPO É DENTE)

PRINCÍPIO FUNDAMENTAL — TEMPO É TUDO

REIMPLANTE IMEDIATO É O OBJETIVO (DENTE PERMANENTE)

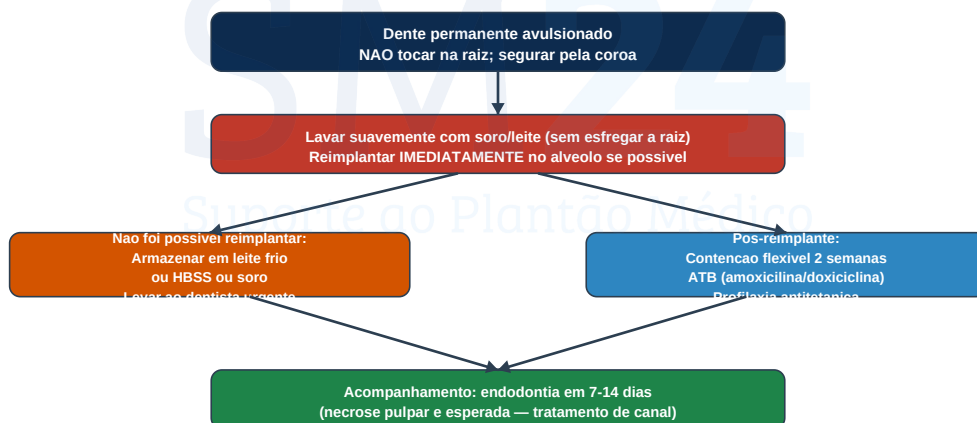
- Avulsão = dente completamente deslocado do alvéolo (saiu da boca)
- O tempo extra-alveolar é o fator prognóstico mais importante para sobrevida do ligamento periodontal
- <30 min fora: melhor prognóstico; >60 min a seco: ligamento periodontal inviável
- Reimplante imediato no local do acidente é a conduta ideal (se dente permanente)
- Dente DECÍDUO (de leite): NÃO reimplantar — risco de dano ao germe do dente permanente
- Reduzir tempo seco: colocar o dente em meio de armazenamento adequado imediatamente

MEIOS DE ARMAZENAMENTO — DO MELHOR AO PIOR

Meio	Qualidade	Tempo de viabilidade
Solução HBSS (Hank's)	Ótimo	Até 24h — mantém ligamento periodontal
Leite frio (UHT/pasteurizado)	Bom	Até 6h — mais disponível na prática
Soro fisiológico	Razoável	2-3h
Saliva (sob a língua, na bochecha)	Razoável	Até 2h (cuidado com deglutição/aspiração)
Água	RUIM — evitar	Hipotônica → lise celular do ligamento; só se não houver alternativa
A seco (sem meio)	PÉSSIMO	>60 min = ligamento periodontal inviável

MANEJO DA AVULSÃO DE DENTE PERMANENTE

AVULSÃO — REIMPLANTAR E ESTABILIZAR



DENTE PERMANENTE vs DECÍDUO

Aspecto	Permanente	Decíduo (de leite)
Reimplante	SIM — o quanto antes	NÃO reimplantar (dano ao germe permanente)
Conduta	Reimplantar + contenção + ATB + endodontia	Limpar alvéolo, controlar sangramento, acompanhar
Meio de transporte	Leite/HBSS/soro até o reimplante	Não aplicável
Prognóstico	Depende do tempo extra-alveolar	Espaço mantido por mantenedor se necessário
Risco do reimplante decíduo	—	Anquilose, infecção, lesão do sucessor permanente

CUIDADOS PÓS-REIMPLANTE

Medicação e Profilaxia

- Antibiótico: amoxicilina (ou doxiciclina em >12 anos) por 7 dias
- Profilaxia antitetânica: avaliar esquema vacinal (ferida contaminada)
- Analgesia: AINE para dor
- Bochechos com clorexidina 0,12% 2x/dia por 1 semana
- Dieta líquida/pastosa nos primeiros dias
- Higiene oral cuidadosa para evitar infecção

Contenção e Seguimento

- Contenção semirrígida/flexível por ~2 semanas (permite mobilidade fisiológica)
- Endodontia: tratamento de canal em 7-14 dias (necrose pulpar esperada em dente maduro)
- Dente com ápice aberto (imaturo): pode revascularizar — acompanhar
- Controle radiográfico: avaliar reabsorção radicular e anquilose
- Complicações: reabsorção radicular externa, anquilose, perda do dente
- Acompanhamento odontológico a longo prazo (meses)

PASSO A PASSO NO LOCAL DO ACIDENTE

ORIENTAÇÃO LEIGA E PROFISSIONAL

- ☐ Encontrar o dente e segurá-lo pela COROA (nunca pela raiz)
- ☐ Se sujo: lavar rapidamente com soro/leite/água SEM esfregar (não remover o ligamento)
- ☐ Reimplantar imediatamente no alvéolo, na posição correta, e morder uma gaze
- ☐ Se não puder reimplantar: armazenar em leite frio, HBSS, soro ou saliva (NUNCA água por longo tempo)
- ☐ Procurar atendimento odontológico de urgência IMEDIATAMENTE
- ☐ NÃO reimplantar dente decíduo (de leite) — apenas controlar sangramento e procurar dentista

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Criança de 10 anos com avulsão de incisivo central PERMANENTE há 15 minutos, dente em mãos do acompanhante. Qual é a conduta ideal?

- A) Descartar o dente e encaminhar para prótese
- B) Lavar suavemente (sem esfregar a raiz) e reimplantar imediatamente no alvéolo + contenção + ATB
- C) Armazenar em água e aguardar atendimento eletivo
- D) Reimplantar apenas após 24h em consultório
- E) Colocar o dente no congelador para preservar

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o melhor meio de armazenamento para um dente avulsionado quando o reimplante imediato não é possível e não há HBSS disponível?

- A) Água da torneira
- B) Leite frio
- C) Álcool
- D) Gaze seca
- E) Papel toalha úmido

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Em relação à avulsão de dente DECÍDUO (de leite), qual é a conduta correta?

- A) Reimplantar imediatamente como no permanente
- B) NÃO reimplantar — risco de dano ao germe do dente permanente; controlar sangramento e acompanhar
- C) Armazenar em leite e reimplantar em consultório
- D) Reimplantar apenas se o tempo for menor que 30 minutos
- E) Reimplantar e fazer endodontia imediata

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Por que NÃO se deve segurar o dente avulsionado pela raiz nem esfregá-la?

- A) Porque a raiz é mais frágil e pode quebrar
- B) Para preservar as células do ligamento periodontal aderidas à raiz, essenciais para a sobrevida do reimplante
- C) Porque a raiz contém o esmalte dental
- D) Para evitar contaminação da coroa
- E) Porque a raiz transmite sensibilidade dolorosa

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual é o fator prognóstico MAIS importante para a sobrevida de um dente permanente reimplantado?

- A) A idade do paciente
- B) O tipo de dente avulsionado
- C) O tempo extra-alveolar e o meio de armazenamento (quanto menor o tempo a seco, melhor)
- D) O uso de antibiótico
- E) A técnica de contenção utilizada

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Dente permanente avulsionado há 15 min: reimplante imediato é o ideal. Segurar pela coroa, lavar suavemente sem esfregar a raiz (preserva ligamento periodontal), reimplantar no alvéolo + contenção flexível 2 semanas + ATB + profilaxia antitetânica + endodontia em 7-14 dias.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Leite frio é o meio de armazenamento mais prático e disponível (pH e osmolaridade compatíveis, mantém viabilidade do ligamento periodontal por até 6h). HBSS é o ideal mas raramente disponível. Água é hipotônica e causa lise celular — deve ser evitada.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Dente decíduo (de leite) NÃO deve ser reimplantado — o reimplante pode danificar o germe do dente permanente sucessor (anquilose, infecção, alterações de erupção). Conduta: controlar o sangramento, limpar o alvéolo e acompanhar; mantenedor de espaço se necessário.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

As células do ligamento periodontal aderidas à superfície radicular são essenciais para a reinserção e sobrevida do dente reimplantado. Esfregar ou tocar na raiz remove/danifica essas células, comprometendo o prognóstico. Segurar pela coroa e lavar sem esfregar.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

O tempo extra-alveolar (especialmente a seco) e o meio de armazenamento são os fatores prognósticos mais importantes. <30 min: ótimo; >60 min a seco: ligamento periodontal inviável (anquilose/reabsorção). Por isso a orientação de reimplante imediato ou armazenamento em meio adequado.

SM24
Suporte ao Plantão Médico